Production 50 / 50

143 cours prioritaires proposés et 23 catégories à arbitrer

PREPARE_NON_LANCE
Planification seule. Aucun audit croisé à ce stade, aucun ordre envoyé à Claude. Les gardes et la coordination proposées doivent être adaptées et vérifiées avant toute correction canonique ou production.



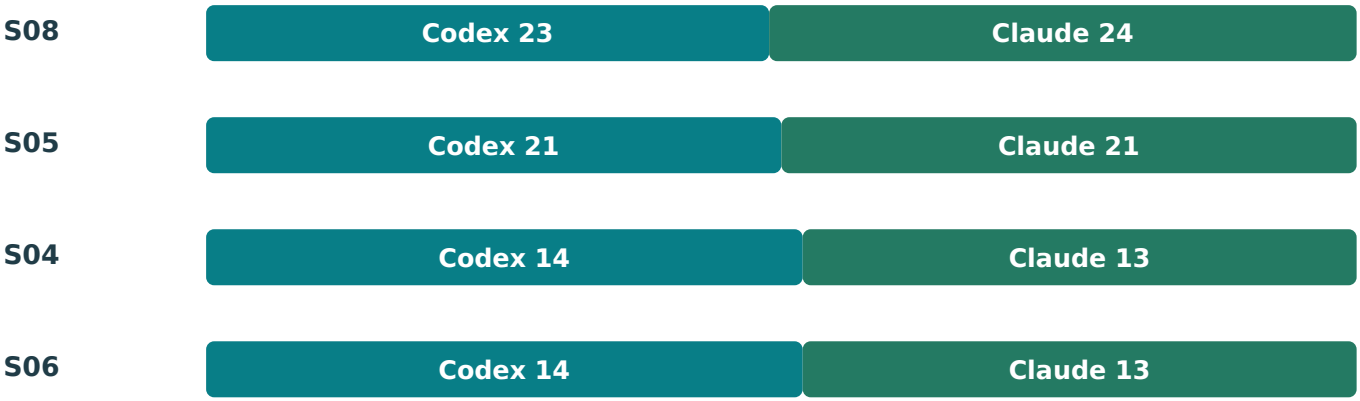
L’inventaire contient 270 catégories racines : 104 cours existants à auditer, 143 nouvelles priorités étoilées et 23 réserves sans étoile. Si les 23 réserves sont retenues : 166 cours nouveaux, 83 Codex et 83 Claude. Une catégorie non étoilée n’est jamais réputée hors programme.

Un cours entier, une attribution claire

Les sous-codes restent dans la leçon mère. Une branche, un worktree et des chemins propres par tâche ; fichiers partagés remis à un seul intégrateur, rôle temporaire ouvert également aux deux IA. Le cache économise les relectures sans remplacer les preuves.

Base documentaire : 7adf385a5182a8dcf25584dbb53207c620440ad3. Les listes et empreintes complètes figurent dans plan.json ; ces documents décrivent des attributions proposées, jamais une validation médicale humaine.

La parité, système par système



Fragment	N	Codex	Claude	Charge indicative C / Cl
N-05-Neurologie	47	23	24	903 / 911
E-06-Endocrinologie et métabolisme	42	21	21	699 / 682
N-07-Néphrologie	27	14	13	522 / 505
H-08-Hématologie	27	14	13	560 / 549

Chaque leçon complète appartient à une seule IA. Les effectifs impairs entraînent un écart d’un cours, compensé entre systèmes lorsque possible. Les attributions équilibrent aussi les chapitres CIM ; aucune moitié de cours n’est utilisée pour fabriquer le quota.

La charge production est un indice heuristique : 20 + nombre de sous-codes (plafonné à 30) + 3 × SSP + supplément de priorité (20 / 8 / 0). Le pilote doit le recalibrer ; cet indice ne mesure ni le temps réel ni le risque clinique.

Les chapitres, sans déséquilibre caché

C / Cl = Codex / Claude. Un chapitre CIM peut contribuer à plusieurs fragments ; chaque ligne garde le fragment de rattachement. Le périmètre reste les quatre systèmes attribués.

Fragment / chapitre	Intitulé	N	C / Cl
S08 / II	Tumeurs	1	0 / 1
S08 / IX	Maladies de l’appareil circulatoire	2	1 / 1
S08 / VI	Maladies du système nerveux	19	9 / 10
S08 / XIX	Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes	11	6 / 5
S08 / XVII	Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	8	4 / 4
S08 / XVIII	Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs	6	3 / 3
S05 / II	Tumeurs	3	2 / 1
S05 / IV	Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	39	19 / 20
S04 / II	Tumeurs	3	2 / 1
S04 / XIV	Maladies de l’appareil génito-urinaire	18	9 / 9
S04 / XIX	Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes	1	0 / 1
S04 / XVII	Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	4	2 / 2
S04 / XXI	Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé	1	1 / 0
S06 / II	Tumeurs	8	4 / 4
S06 / III	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	19	10 / 9

Le périmètre fédéral reste à qualifier

Inventaire	Catégories racines	Décision
Cours existants	104	Audit Alpha : 52 / 52
Nouveaux candidats étoilés	143	Priorité pédagogique proposée : 72 / 71
Sans étoile, non exclus	23	Attribution conservatoire : 11 / 12 ; arbitrage requis
Total des quatre systèmes	270	104 + 143 + 23 ; pas de dédoublement automatique

L’étoile provient du mapper pédagogique PROFILES/SSP du dépôt. official_icd_crosswalk=false : elle n’atteste pas une liste officielle de maladies de l’examen fédéral. Les 1 967 lignes étoilées vides — 143 catégories et 1 824 sous-codes — ne constituent pas 1 967 cours distincts. Les 744 sous-codes rattachés aux 104 cours existants sont à vérifier en Alpha ; les 1 080 sous-codes rattachés aux 143 nouveaux cours sont à couvrir ; 137 sous-codes relèvent des 23 réserves.

Les 23 catégories sans étoile, notamment E16, demandent une vérification individuelle de leur pertinence SSP. L’absence d’étoile peut refléter une limite de correspondance. Aucun sujet n’est déclaré hors examen ; l’arbitrage doit être versionné avant lancement, avec le traitement réservé à chaque catégorie.

Fragment	Priorités	Réserves	Nouveaux si retenus
S08	47	12	59
S05	42	9	51
S04	27	0	27
S06	27	2	29

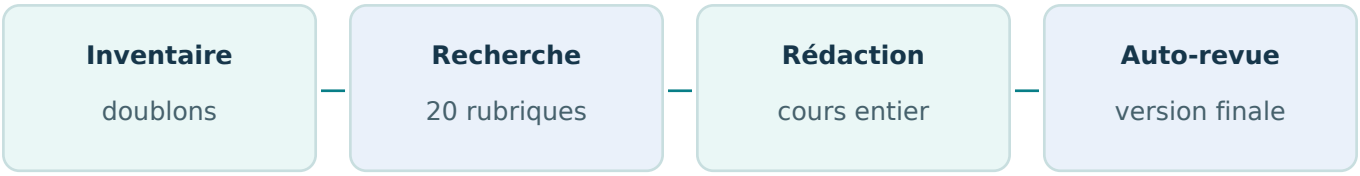
La chaîne de production proposée

Le contrat médical et la langue

Chaque fait vient d’un passage réellement consulté. Les sources suisses applicables précèdent les européennes. Aucune recommandation américaine ne fonde une conduite. Pour chaque médicament : information professionnelle suisse du produit exact, datée, avec forme, dose, voie, fréquence, durée, maximum et adaptations pertinentes.

Le français est précis, élégant et engageant : phrases complètes, progression normal → mécanisme → conséquence → décision, tableaux expliqués et figures commentées. Les reformulations conservent les chiffres, négations, conditions et degrés de certitude ; les approfondissements restent accessibles dans les fenêtres.

> Une preuve manquante reste une lacune. Une auto-relecture n’est pas un audit indépendant ; un contrôle structurel n’établit ni la vérité médicale ni une validation par un médecin.



Avant de commencer, examiner les sources canoniques et les branches/livraisons existantes. Reprendre une préparation pertinente au lieu de recréer son cours ; R29, R48 et E60 peuvent déjà avoir des matériaux sans être des cours canoniques. Un cours nouveau ne recouvre pas une catégorie déjà attribuée par covers.

Une passe complète, puis une vérification utile

Séquence après lancement	Livrable vérifiable
1. Entrée et inventaire	Contrat compact chargé ; SHA, manifeste, surfaces et sous-codes identifiés ; doublons et attributions vérifiés.
2. Lecture et recherche	Lecture complète du contenu attribué ; passages applicables et matrice ; décisions critiques vérifiées en contexte suisse.
3. Correction ou rédaction	Une IA responsable du cours entier, uniquement sur chemins propres ; français relu ; chiffres, conditions et incertitudes conservés.
4. Auto-relecture finale	Relecture du résultat et de ses dépendances modifiées ; tests réellement exécutés sur les empreintes finales ; constats résolus ou réserves explicites.
5. Remise bornée	Rapport concis, avant/après, sources et vérifications ; aucune chaîne automatique de renvois entre IA. Blocage persistant : arrêter la leçon concernée et documenter.

Les décisions cliniques priment sur la note

Urgences et délais, diagnostic, traitements, contre-indications et suivi sont vérifiés exhaustivement. Distinguer normalité, seuil diagnostique et cible avec unités et population. Une contradiction est arbitrée par actualité et applicabilité ; une lacune ne devient pas une recommandation par une simple reformulation élégante.

Le but est un dossier assez solide pour faciliter une revue ultérieure. Aucun prompt, cache ou contrôle ne garantit qu’un audit différé sera quasi négligeable, sans omission ou équivalent à une validation médicale humaine.

La matrice des 20 rubriques

Ordre exact du Prompt de vérité. Chaque ligne reçoit « couvert » avec source et passage, « sans objet » motivé, ou « LACUNE » avec recherche tentée. Le rapport final ajoute l'onglet et l'identifiant HTML. Aucun statut n'est prérempli favorablement.

N°	Rubrique obligatoire
1	Question clinique et enjeu pour l'examen fédéral
2	Définition et périmètre CIM-10-GM (libellés OFS, inclusions, exclusions, notes BfArM)
3	Classifications et stades
4	Épidémiologie suisse puis européenne (incidence, prévalence, âge, sexe)
5	Normal → pathologique (anatomie, physiologie, mécanisme causal)
6	Étiologies et facteurs de risque
7	Anamnèse et symptômes (fréquences)
8	Examen clinique (signes, sensibilité/spécificité si disponibles)
9	Drapeaux rouges et urgences (seuil, délai, action)
10	Examens complémentaires (indication, valeur normale, seuil, interprétation, pièges)
11	Diagnostic différentiel (élément discriminant pour chaque diagnostic)
12	Prise en charge suisse (niveaux de soins, conduite, médicaments FI datés)
13	Complications et pronostic
14	Suivi, prévention, dépistage
15	Situations particulières (grossesse, enfant, âgé, insuffisance rénale/hépatique)
16	Spécificités suisses (déclaration OFSP, Suva/LAA, aptitude à la conduite, AI, remboursement LS/LiMA)
17	Critères formels du diagnostic (→ div.alert)
18	Paramètres clés chiffrés (→ div.key)
19	Sous-codes CIM-10-GM couverts (liste complète X00.0… et leur traitement)
20	Points d'examen fédéral (objectifs PROFILES/SSP, pièges classiques)

Dossier de preuves et cache fiable

Document de la leçon	Contenu minimal
recherche.md	Question clinique, plan des recherches et matrice exacte des 20 rubriques ; requêtes infructueuses et limites.
sources.json	Identifiant Sx, URL, titre/éditeur, version, consultation, section/page, niveau de lecture, population et limites ; produit suisse exact si médicament.
rapport.md / constats	Gravité, emplacement, source et passage, correction, contrôle du résultat, réserves et actions restantes.
missions/[identifiant].json	270 manifestes préparés, non lancés : base SHA40, mission, chemins, empreintes des sources et dépendances/assets. Les ressources externes inventoriées ne sont pas des passages déjà lus.
Contrôles et captures	Résultat réel de chaque contrôle, version finale testée ; captures ouverture et fenêtre explicative dans un dossier exclusif.

Réutiliser les preuves sans fabriquer une nouvelle lecture

Charger une fois le socle par empreinte et ouvrir seulement ses sections nécessaires ou changées. Le cache identifie le contenu par SHA-256, sa provenance, le lecteur, le passage consulté et son contexte. Réutiliser une preuve applicable ne signifie pas l’avoir relue. Ne pas recopier des documents entiers dans les prompts ou les dossiers.

Invalider la preuve si la source, sa version, la population, la décision ou une dépendance change. Relire le paragraphe et ses surfaces liées : fenêtres, tableaux, figures, quiz, résumés et autres onglets. Une correction de dose impose de vérifier ses adaptations et contre-indications, même si elles sont ailleurs.

Les lots de conversation

Un lot logistique regroupe normalement 3–4 cours entiers. Un reliquat de 1–2 ou une monographie lourde reste possible. Une conversation de lot conserve une tâche et un dossier distincts par cours ; chaque livraison avance séparément, sans attendre la fin du lot.

Lot	IA	Cours attribués
PA-S08-CODEX-01	Codex	G00, G04, G41, I60
PA-S08-CODEX-02	Codex	R40, G20, G30, G40
PA-S08-CODEX-03	Codex	G43, G31, G35, Q01
PA-S08-CODEX-04	Codex	Q02, Q03, Q04, R41
PA-S08-CODEX-05	Codex	R42, S04, S14, S24
PA-S08-CODEX-06	Codex	S44, S54, S64
PA-S08-CLAUDE-01	Claude	G61, G70, S06, G44
PA-S08-CLAUDE-02	Claude	G47, G56, G62, C71
PA-S08-CLAUDE-03	Claude	G50, G51, G54, G95
PA-S08-CLAUDE-04	Claude	I69, Q00, Q05, Q06
PA-S08-CLAUDE-05	Claude	Q07, R29, R48, R49
PA-S08-CLAUDE-06	Claude	S34, S74, S84, S94
PA-S05-CODEX-01	Codex	E27, C73, C74, E06
PA-S05-CODEX-02	Codex	E13, E20, E21, E22
PA-S05-CODEX-03	Codex	E23, E24, E26, E28
PA-S05-CODEX-04	Codex	E29, E31, E43, E44
PA-S05-CODEX-05	Codex	E53, E55, E60, E63
PA-S05-CODEX-06	Codex	E64
PA-S05-CLAUDE-01	Claude	E03, E04, E66, E78
PA-S05-CLAUDE-02	Claude	C75, E61, E65, E67

Les lots de conversation — suite

Lot	IA	Cours attribués
PA-S05-CLAUDE-03	Claude	E68, E70, E71, E72
PA-S05-CLAUDE-04	Claude	E73, E74, E75, E76
PA-S05-CLAUDE-05	Claude	E77, E84, E85, E86
PA-S05-CLAUDE-06	Claude	E87
PA-S04-CODEX-01	Codex	N00, C64, C65, N02
PA-S04-CODEX-02	Codex	N03, N05, N06, N07
PA-S04-CODEX-03	Codex	N10, N11, N14, Q60
PA-S04-CODEX-04	Codex	Q61, Z49
PA-S04-CLAUDE-01	Claude	N01, C66, N08, N13
PA-S04-CLAUDE-02	Claude	N15, N16, N19, N25
PA-S04-CLAUDE-03	Claude	N26, N28, Q62, Q63
PA-S04-CLAUDE-04	Claude	S37
PA-S06-CODEX-01	Codex	C92, D62, D65, D66
PA-S06-CODEX-02	Codex	C81, C83, C88, D51
PA-S06-CODEX-03	Codex	D52, D53, D55, D56
PA-S06-CODEX-04	Codex	D57, D59
PA-S06-CLAUDE-01	Claude	C91, D67, D68, D70
PA-S06-CLAUDE-02	Claude	C82, C84, C90, D58
PA-S06-CLAUDE-03	Claude	D60, D61, D72, D75
PA-S06-CLAUDE-04	Claude	D76

Ces lots sont des regroupements préparés, pas des conversations actives. Au lancement, sortir les quatre cours pilotes de leur lot sans les dupliquer. Commencer au plus deux missions simultanées par IA puis ajuster la capacité à la qualité mesurée ; scinder les tâches lourdes plutôt que raccourcir les vérifications.

N-05-Neurologie / Productions prioritaires

Chaque catégorie à trois caractères correspond à un cours entier. SSP = rattachement pédagogique du dépôt, non correspondance officielle de maladies. P0/P1/P2 = ordre éditorial proposé, à recalibrer. « Sous » = nombre de sous-codes descendants à couvrir explicitement.

Le plan JSON donne les sous-codes exacts, identifiants, lots et chemins. Réserves : attribution conservatoire, sans rédaction avant arbitrage.

Chapitre II — Tumeurs

Bloc C69-C72 — Tumeurs malignes de l'œil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
C71 — Tumeur maligne de l'encéphale	Claude	P2	159, 227	10

Chapitre VI — Maladies du système nerveux

Bloc G00-G09 — Maladies inflammatoires du système nerveux central

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
G00 — Méningite bactérienne, non classée ailleurs	Codex	P0	6, 101, 207	6
G04 — Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	Codex	P0	6, 101, 207	5

Chapitre VI — Maladies du système nerveux

Bloc G20-G26 — Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
G20 — Maladie de Parkinson	Codex	P1	98	12

Chapitre VI — Maladies du système nerveux

Bloc G30-G32 — Autres affections dégénératives du système nerveux

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
G30 — Maladie d’Alzheimer	Codex	P1	102, 139	4
G31 — Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	Codex	P2	102, 139	8

Chapitre VI — Maladies du système nerveux

Bloc G35-G37 — Maladies démyélinisantes du système nerveux central

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
G35 — Sclérose en plaques	Codex	P2	103, 104	11

Chapitre VI — Maladies du système nerveux

Bloc G40-G47 — Affections épisodiques et paroxystiques

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
G40 — Épilepsie	Codex	P1	105, 219	15
G41 — État de mal épileptique	Codex	P0	105, 219	5
G43 — Migraine	Codex	P1	101	6
G44 — Autres syndromes d’algies céphaliques	Claude	P1	101	6
G47 — Troubles du sommeil	Claude	P1	11, 40	12

Chapitre VI — Maladies du système nerveux

Bloc G50-G59 — Affections des nerfs et des racines et plexus nerveux

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
G50 — Affections du nerf trijumeau [nerf crânien V]	Claude	P2	85, 104	4
G51 — Affections du nerf facial [nerf crânien VII]	Claude	P2	85, 104	7
G54 — Affections des racines et des plexus nerveux	Claude	P2	85, 104	10
G56 — Mononévrite du membre supérieur	Claude	P1	85, 104	6

Chapitre VI — Maladies du système nerveux

Bloc G60-G64 — Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
G61 — Polynévrites inflammatoires	Claude	P0	85, 104	4
G62 — Autres polynévrites	Claude	P1	85, 104	7

Chapitre VI — Maladies du système nerveux

Bloc G70-G73 — Affections musculaires et neuromusculaires

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
G70 — Myasthénie et autres affections neuromusculaires	Claude	P0	103, 194	5

Chapitre VI — Maladies du système nerveux

Bloc G90-G99 — Autres affections du système nerveux

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
G95 — Autres affections de la moelle épinière	Claude	P2	103, 104	14

Chapitre IX — Maladies de l’appareil circulatoire

Bloc I60-I69 — Maladies cérébrovasculaires

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
I60 — Hémorragie sous-arachnoïdienne	Codex	P0	103, 205	10
I69 — Séquelles de maladies cérébrovasculaires	Claude	P2	103, 205	6

Chapitre XVII — Malformations congénitales et anomalies chromosomiques

Bloc Q00-Q07 — Malformations congénitales du système nerveux

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
Q00 — Anencéphalie et malformations similaires	Claude	P2	70, 177	3
Q01 — Encéphalocèle	Codex	P2	70, 177	5
Q02 — Microcéphalie	Codex	P2	70, 177	0
Q03 — Hydrocéphalie congénitale	Codex	P2	70, 177	4
Q04 — Autres malformations congénitales de l’encéphale	Codex	P2	70, 177	9

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
Q05 — Spina bifida	Claude	P2	70, 177	10
Q06 — Autres malformations congénitales de la moelle épinière	Claude	P2	70, 177	7
Q07 — Autres malformations congénitales du système nerveux	Claude	P2	70, 177	3

Chapitre XVIII — Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs

Bloc R25-R29 — Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
R29 — Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	Claude	P2	96, 97, 98, 103	8

Chapitre XVIII — Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs

Bloc R40-R46 — Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l’humeur et le comportement

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
R40 — Somnolence, stupeur et coma	Codex	P0	145, 217	3
R41 — Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience	Codex	P2	102, 126, 139	5
R42 — Étourdissements et éblouissements	Codex	P2	100	0

Chapitre XVIII — Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs

Bloc R47-R49 — Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
R48 — Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs	Claude	P2	19, 99	4
R49 — Troubles de la voix	Claude	P2	19, 99	4

Chapitre XIX — Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes

Bloc S00-S09 — Lésions traumatiques de la tête

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
S04 — Lésion traumatique des nerfs crâniens	Codex	P2	112	10
S06 — Lésion traumatique intracrânienne	Claude	P0	112	26

Chapitre XIX — Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes

Bloc S10-S19 — Lésions traumatiques du cou

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
S14 — Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou	Codex	P2	115	21

Chapitre XIX — Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes

Bloc S20-S29 — Lésions traumatiques du thorax

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
S24 — Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax	Codex	P2	116	19

Chapitre XIX — Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes

Bloc S30-S39 — Lésions traumatiques de l’abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
S34 — Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l’abdomen, des lombes et du bassin	Claude	P2	106	23

Chapitre XIX — Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes

Bloc S40-S49 — Lésions traumatiques de l’épaule et du bras

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
S44 — Lésion traumatique de nerfs au niveau de l’épaule et du bras	Codex	P2	113, 220	9

Chapitre XIX — Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes

Bloc S50-S59 — Lésions traumatiques du coude et de l’avant-bras

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
S54 — Lésion traumatique de nerfs au niveau de l’avant-bras	Codex	P2	113, 220	7

Chapitre XIX — Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes

Bloc S60-S69 — Lésions traumatiques du poignet et de la main

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
S64 — Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main	Codex	P2	113, 220	8

Chapitre XIX — Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes

Bloc S70-S79 — Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
S74 — Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse	Claude	P2	113, 220	6

Chapitre XIX — Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes

Bloc S80-S89 — Lésions traumatiques du genou et de la jambe

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
S84 — Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe	Claude	P2	113, 220	6

Chapitre XIX — Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes

Bloc S90-S99 — Lésions traumatiques de la cheville et du pied

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
S94 — Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied	Claude	P2	113, 220	7

E-06-Endocrinologie et métabolisme / Productions prioritaires

Chaque catégorie à trois caractères correspond à un cours entier. SSP = rattachement pédagogique du dépôt, non correspondance officielle de maladies. P0/P1/P2 = ordre éditorial proposé, à recalibrer. « Sous » = nombre de sous-codes descendants à couvrir explicitement.

Le plan JSON donne les sous-codes exacts, identifiants, lots et chemins. Réserves : attribution conservatoire, sans rédaction avant arbitrage.

Chapitre II — Tumeurs

Bloc C73-C75 — Tumeurs malignes de la thyroïde et d’autres glandes endocrines

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
C73 — Tumeur maligne de la thyroïde	Codex	P2	159, 227	0
C74 — Tumeur maligne de la surrénale	Codex	P2	159, 227	3
C75 — Tumeur maligne d’autres glandes endocrines et structures apparentées	Claude	P2	159, 227	8

Chapitre IV — Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Bloc E00-E07 — Affections de la glande thyroïde

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
E03 — Autres hypothyroïdies	Claude	P1	37, 163	8
E04 — Autres goitres non toxiques	Claude	P1	37, 163	5
E06 — Thyroïdite	Codex	P2	37, 163	7

Chapitre IV — Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Bloc E10-E14 — Diabète sucré

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
E13 — Autres diabètes sucrés précisés	Codex	P2	3, 158	30

Chapitre IV — Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Bloc E20-E35 — Maladies des autres glandes endocrines

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
E20 — Hypoparathyroïdie	Codex	P2	156, 184	4
E21 — Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde	Codex	P2	156, 184	6
E22 — Hypersécrétion de l’hypophyse	Codex	P2	156, 184	5
E23 — Hyposécrétion et autres anomalies de l’hypophyse	Codex	P2	156, 184	6
E24 — Syndrome de Cushing	Codex	P2	156, 184	7
E26 — Hyperaldostéronisme	Codex	P2	156, 184	4
E27 — Autres maladies de la glande surrénale	Codex	P0	156, 184	8
E28 — Dysfonction ovarienne	Codex	P2	156, 184	6
E29 — Dysfonction testiculaire	Codex	P2	156, 184	4
E31 — Dysfonctionnement pluriglandulaire	Codex	P2	156, 184	4

Chapitre IV — Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Bloc E40-E46 — Malnutrition

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
E43 — Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision	Codex	P2	16, 138, 170	0
E44 — Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée	Codex	P2	16, 138, 170	2

Chapitre IV — Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Bloc E50-E64 — Autres carences nutritionnelles

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
E53 — Autres avitaminoses du groupe B	Codex	P2	16, 138, 170	4
E55 — Carence en vitamine D	Codex	P2	16, 138, 170	2
E60 — Carence alimentaire en zinc	Codex	P2	16, 138, 170	0
E61 — Carences en autres éléments nutritionnels	Claude	P2	16, 138, 170	10
E63 — Autres carences nutritionnelles	Codex	P2	16, 138, 170	4

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
E64 — Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles	Codex	P2	16, 138, 170	6

Chapitre IV — Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Bloc E65-E68 — Obésité et autres excès d’apport

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
E65 — Adiposité localisée	Claude	P2	15	0
E66 — Obésité	Claude	P1	15	45
E67 — Autres excès d’apport	Claude	P2	15	5
E68 — Séquelles d’excès d’apport	Claude	P2	15	0

Chapitre IV — Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Bloc E70-E90 — Anomalies du métabolisme

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
E70 — Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques	Claude	P2	264	6
E71 — Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras	Claude	P2	264	4
E72 — Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	Claude	P2	264	8
E73 — Intolérance au lactose	Claude	P2	264	4
E74 — Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone	Claude	P2	264	7
E75 — Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides	Claude	P2	264	7
E76 — Anomalies du métabolisme des glucosaminoglycanes	Claude	P2	264	6
E77 — Anomalies du métabolisme des glycoprotéines	Claude	P2	264	4
E78 — Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies	Claude	P1	162	11
E84 — Fibrose kystique	Claude	P2	46, 189	7
E85 — Amylose	Claude	P2	146, 173	7

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
E86 — Hypovolémie	Claude	P2	156	0
E87 — Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	Claude	P2	156	9

N-07-Néphrologie / Productions prioritaires

Chaque catégorie à trois caractères correspond à un cours entier. SSP = rattachement pédagogique du dépôt, non correspondance officielle de maladies. P0/P1/P2 = ordre éditorial proposé, à recalibrer. « Sous » = nombre de sous-codes descendants à couvrir explicitement.

Le plan JSON donne les sous-codes exacts, identifiants, lots et chemins. Réserves : attribution conservatoire, sans rédaction avant arbitrage.

Chapitre II — Tumeurs

Bloc C64-C68 — Tumeurs malignes des voies urinaires

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
C64 — Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet	Codex	P2	159, 227	0
C65 — Tumeur maligne du bassinet	Codex	P2	159, 227	0
C66 — Tumeur maligne de l’uretère	Claude	P2	159, 227	0

Chapitre XIV — Maladies de l’appareil génito-urinaire

Bloc N00-N08 — Glomérulopathies

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
N00 — Syndrome néphritique aigu	Codex	P0	63, 161, 164, 173	10
N01 — Syndrome néphritique d’évolution rapide	Claude	P0	63, 161, 164, 173	10
N02 — Hématurie récidivante et persistante	Codex	P2	63, 161, 164, 173	10
N03 — Syndrome néphritique chronique	Codex	P2	63, 161, 164, 173	10
N05 — Syndrome néphritique, sans précision	Codex	P2	63, 161, 164, 173	10
N06 — Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées	Codex	P2	63, 161, 164, 173	10
N07 — Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs	Codex	P2	63, 161, 164, 173	10

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
N08 — Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs	Claude	P2	63, 161, 164, 173	7

Chapitre XIV — Maladies de l’appareil génito-urinaire

Bloc N10-N16 — Maladies rénales tubulo-interstitielles

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
N10 — Néphrite tubulo-interstitielle aiguë	Codex	P2	63, 161, 164, 173	0
N11 — Néphrite tubulo-interstitielle chronique	Codex	P2	63, 161, 164, 173	4
N13 — Uropathie obstructive et par reflux	Claude	P2	63, 161, 164, 173	22
N14 — Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds	Codex	P2	63, 161, 164, 173	5
N15 — Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	Claude	P2	63, 161, 164, 173	6
N16 — Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs	Claude	P2	63, 161, 164, 173	7

Chapitre XIV — Maladies de l’appareil génito-urinaire

Bloc N17-N19 — Insuffisance rénale

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
N19 — Insuffisance rénale, sans précision	Claude	P2	63, 161, 164, 173	0

Chapitre XIV — Maladies de l’appareil génito-urinaire

Bloc N25-N29 — Autres affections du rein et de l’uretère

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
N25 — Affections dues à une tubulopathie	Claude	P2	64, 76, 77	4
N26 — Rein scléreux, sans précision	Claude	P2	64, 76, 77	0
N28 — Autres affections du rein et de l’uretère, non classées ailleurs	Claude	P2	64, 76, 77	6

Chapitre XVII — Malformations congénitales et anomalies chromosomiques

Bloc Q60-Q64 — Malformations congénitales de l’appareil urinaire

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
Q60 — Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal	Codex	P2	70, 177	7
Q61 — Maladies kystiques du rein	Codex	P2	70, 177	8
Q62 — Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l’uretère	Claude	P2	70, 177	9
Q63 — Autres malformations congénitales du rein	Claude	P2	70, 177	6

Chapitre XIX — Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes

Bloc S30-S39 — Lésions traumatiques de l’abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
S37 — Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires	Claude	P2	106	28

Chapitre XXI — Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé

Bloc Z40-Z54 — Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
Z49 — Surveillance d’une dialyse	Codex	P2	255	3

H-08-Hématologie / Productions prioritaires

Chaque catégorie à trois caractères correspond à un cours entier. SSP = rattachement pédagogique du dépôt, non correspondance officielle de maladies. P0/P1/P2 = ordre éditorial proposé, à recalibrer. « Sous » = nombre de sous-codes descendants à couvrir explicitement.

Le plan JSON donne les sous-codes exacts, identifiants, lots et chemins. Réserves : attribution conservatoire, sans rédaction avant arbitrage.

Chapitre II — Tumeurs

Bloc C81-C96 — Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
C81 — Lymphome de Hodgkin [lymphogranulomatose maligne]	Codex	P2	159, 227	7
C82 — Lymphome folliculaire	Claude	P2	159, 227	9
C83 — Lymphome non folliculaire	Codex	P2	159, 227	7
C84 — Lymphomes à cellules T/NK matures	Claude	P2	159, 227	8
C88 — Maladies immunoprolifératives malignes	Codex	P2	159, 227	18
C90 — Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	Claude	P2	159, 227	12
C91 — Leucémie lymphoïde	Claude	P0	159, 227	27
C92 — Leucémie myéloïde	Codex	P0	159, 227	30

Chapitre III — Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire

Bloc D50-D53 — Anémies nutritionnelles

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
D51 — Anémie par carence en vitamine B12	Codex	P2	147, 165	6
D52 — Anémie par carence en acide folique	Codex	P2	147, 165	4
D53 — Autres anémies nutritionnelles	Codex	P2	147, 165	5

Chapitre III — Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire

Bloc D55-D59 — Anémies hémolytiques

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
D55 — Anémie due à des anomalies enzymatiques	Codex	P2	147, 165	6
D56 — Thalassémie	Codex	P2	147, 165	7
D57 — Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]	Codex	P2	147, 165	5
D58 — Autres anémies hémolytiques héréditaires	Claude	P2	147, 165	5
D59 — Anémie hémolytique acquise	Codex	P2	147, 165	11

Chapitre III — Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire

Bloc D60-D64 — Aplasies médullaires [anémie aplastique] et autres anémies

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
D60 — Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure [érythroblastopénie]	Claude	P2	147, 165	4
D61 — Autres anémies aplastiques	Claude	P2	147, 165	9
D62 — Anémie posthémorragique aiguë	Codex	P0	147, 165	0

Chapitre III — Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire

Bloc D65-D69 — Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
D65 — Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]	Codex	P0	88, 152, 174	4
D66 — Carence héréditaire en facteur VIII	Codex	P0	88, 152, 174	0
D67 — Carence héréditaire en facteur IX	Claude	P0	88, 152, 174	0
D68 — Autres anomalies de la coagulation	Claude	P0	88, 152, 174	26

Chapitre III — Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire

Bloc D70-D77 — Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
D70 — Agranulocytose et neutropénie	Claude	P0	154, 171	13
D72 — Autres anomalies des leucocytes	Claude	P2	154, 171	4
D75 — Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	Claude	P2	154, 171	4
D76 — Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire	Claude	P2	154, 171	4

N-05-Neurologie / Réserves à arbitrer

Chaque catégorie à trois caractères correspond à un cours entier. SSP = rattachement pédagogique du dépôt, non correspondance officielle de maladies. P0/P1/P2 = ordre éditorial proposé, à recalibrer. « Sous » = nombre de sous-codes descendants à couvrir explicitement.

Le plan JSON donne les sous-codes exacts, identifiants, lots et chemins. Réserves : attribution conservatoire, sans rédaction avant arbitrage.

Chapitre II — Tumeurs

Bloc D10-D36 — Intitulé à documenter dans l’inventaire

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
D32 — Tumeur bénigne des méninges	Codex	P2	À arbitrer	3

Chapitre II — Tumeurs

Bloc D37-D48 — Intitulé à documenter dans l’inventaire

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
D42 — Tumeur des méninges à évolution imprévisible ou inconnue	Claude	P2	À arbitrer	3

Chapitre VI — Maladies du système nerveux

Bloc G10-G14 — Intitulé à documenter dans l’inventaire

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
G10 — Chorée de Huntington	Codex	P2	À arbitrer	0
G11 — Ataxie héréditaire	Codex	P2	À arbitrer	7
G12 — Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	Codex	P2	À arbitrer	5
G13 — Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d’affections classées ailleurs	Claude	P2	À arbitrer	4
G14 — Syndrome post-poliomyélitique	Claude	P2	À arbitrer	0

Chapitre VI — Maladies du système nerveux

Bloc G40-G47 — Intitulé à documenter dans l’inventaire

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
G46 — Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires	Claude	P2	À arbitrer	9

Chapitre XVIII — Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs

Bloc R40-R46 — Intitulé à documenter dans l’inventaire

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
R43 — Troubles de l’odorat et du goût	Codex	P2	À arbitrer	4
R44 — Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales	Claude	P2	À arbitrer	5
R45 — Symptômes et signes relatifs à l’humeur	Codex	P2	À arbitrer	9
R46 — Symptômes et signes relatifs à l’apparence et au comportement	Claude	P2	À arbitrer	9

E-06-Endocrinologie et métabolisme / Réserves à arbitrer

Chaque catégorie à trois caractères correspond à un cours entier. SSP = rattachement pédagogique du dépôt, non correspondance officielle de maladies. P0/P1/P2 = ordre éditorial proposé, à recalibrer. « Sous » = nombre de sous-codes descendants à couvrir explicitement.

Le plan JSON donne les sous-codes exacts, identifiants, lots et chemins. Réserves : attribution conservatoire, sans rédaction avant arbitrage.

Chapitre II — Tumeurs

Bloc D10-D36 — Intitulé à documenter dans l’inventaire

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
D34 — Tumeur bénigne de la thyroïde	Claude	P2	À arbitrer	0

Chapitre IV — Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Bloc E15-E16 — Intitulé à documenter dans l’inventaire

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
E15 — Coma hypoglycémique non diabétique	Codex	P2	À arbitrer	0
E16 — Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne	Codex	P0	À arbitrer	7

Chapitre IV — Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Bloc E70-E90 — Intitulé à documenter dans l’inventaire

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
E79 — Anomalies du métabolisme de la purine et de la pyrimidine	Codex	P2	À arbitrer	4
E80 — Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	Codex	P2	À arbitrer	8
E83 — Anomalies du métabolisme des minéraux	Claude	P2	À arbitrer	15
E88 — Autres anomalies métaboliques	Claude	P2	À arbitrer	11
E89 — Anomalies endocriniennes et métaboliques après des actes médicaux, non classées ailleurs	Claude	P2	À arbitrer	9
E90 — Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs	Claude	P2	À arbitrer	0

H-08-Hématologie / Réserves à arbitrer

Chaque catégorie à trois caractères correspond à un cours entier. SSP = rattachement pédagogique du dépôt, non correspondance officielle de maladies. P0/P1/P2 = ordre éditorial proposé, à recalibrer. « Sous » = nombre de sous-codes descendants à couvrir explicitement.

Le plan JSON donne les sous-codes exacts, identifiants, lots et chemins. Réserves : attribution conservatoire, sans rédaction avant arbitrage.

Chapitre II — Tumeurs

Bloc D10-D36 — Intitulé à documenter dans l’inventaire

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
D18 — Hémangiome et lymphangiome	Codex	P2	À arbitrer	17

Chapitre II — Tumeurs

Bloc D37-D48 — Intitulé à documenter dans l’inventaire

Code — intitulé	IA	P	SSP	Sous
D47 — Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue	Claude	P2	À arbitrer	8

Les adaptations avant toute écriture canonique

Ces protections sont proposées, pas déjà déployées. Le plan ne lance aucune correction, production ou publication. Une première livraison ne doit pas échouer dans une garde historique puis la contourner.

État actuel observé	Adaptation nécessaire au lancement
conversation_workspace.py : role audit exige l'autre IA et une mission auteur locale.	Pour Alpha sans croisement : snapshot détaché générique en lecture seule. Ne pas falsifier --actor ni inventer une mission auteur. Adapter l'outil séparément seulement si nécessaire.
Publication en l'état : provenance exacte et sources existantes identiques.	Une correction médicale ne relève pas de ce reçu. Implémenter et tester un reçu Alpha scoped à S08/S05/S04/S06 : instruction humaine, chemins, avant/après, preuves et statuts réels.
Scellements et preuves historiques conservés.	Ne pas les effacer ou promouvoir artificiellement un statut. Une nouvelle version possède ses propres empreintes ; aucune validation médicale manquante n'est inventée.
Baux locaux limités au .git commun.	Registre central CAS, générations/fencing et file durable d'intégration à implémenter ou allocateur/intégrateur unique effectif avant concurrence intermachines.

Tester l'acceptation d'une tâche valide et le refus des cas suivants : mauvais propriétaire/token, chemin hors périmètre, couverture concurrente, preuve d'ancienne version et modification d'un autre système. Appliquer l'autorité actuelle sans désactiver les gardes ni réécrire les anciens ordres.

Une responsabilité par tâche et par chemin



La clé d’attribution réunit campagne, tâche, cours racine, rôle, IA, conversation, environnement et génération. Deux conversations de Codex sont concurrentes autant que Codex et Claude. Chaque auteur possède sa branche, son worktree, son index Git et ses sorties de build/captures exclusifs.

Réserver à la tâche	Réserver à l’intégrateur unique
chapters/<CODE>/ ; glossary/<code>.py ; figures réellement propres ; dossier de preuves et livraison exclusif.	chapters.json, covers, catégories et alias, nosologie, catalogues de sources globaux, index/jauges, moteurs partagés, registres, workflows et sorties publiées.
Un cours entier et toutes ses surfaces ; sous-codes associés à leur leçon mère ; correction Alpha identifiée séparément, chemins inactifs avant gardes adaptées.	Une mutation de source partagée avec liste de consommateurs et effet attendu ; aucun écrasement d’un ancien catalogue entier.

L’exclusion couvre les préfixes de chemins et l’ensemble racine + covers + sous-codes + alias. Un nom de fichier distinct ne suffit pas si deux tâches traitent la même catégorie. Une image commune n’est pas un fichier propre ; demander sa mutation ou créer une copie propre attribuée.

Le rôle d’intégrateur reste symétrique

Une seule tâche d’intégration à la fois peut être confiée à Codex ou Claude et transférée explicitement. Elle ne confère aucune supériorité administrative et ne change pas la provenance des auteurs. La file durable conserve chaque demande et son reçu ; Actions concurrency seul ne remplace pas cette file.

Entre machines : CAS et générations

Un registre central versionné attribue les tâches par écriture conditionnelle sur son SHA/version précédent : lire, construire la transition, comparer et écrire, puis relire le reçu. Un conflit oblige à relire et recalculer. Une issue avec deux commentaires simultanés ou une mise à jour non conditionnelle de référence Git ne constitue pas une transaction.

Contrôle	Règle opérationnelle
Entrée de registre	Identifiant stable, code/racine/covers, chemins, propriétaire/conversation/environnement, base SHA, état, génération monotone, heartbeat/expiration, livraison et motif de transfert.
Expiration	État « à réconcilier », sans libération automatique. Conserver le travail ; transférer explicitement et augmenter la génération après arrêt confirmé ou exclusion effective de l’ancien auteur.
Fencing	Chaque soumission et intégration vérifie le token courant. Un ancien auteur hors ligne peut continuer à calculer, mais sa livraison obsolète est refusée.
Indisponibilité	Pas de nouvelle acquisition ni intégration sans registre. Lectures et travail déjà exclusif restent possibles, sans publication autonome.
Solution de repli	Si aucun CAS fiable n’est accessible aux deux machines, imposer un seul allocateur/intégrateur effectif ; aucune prise de tâche autonome concurrente.

Le fencing est réel uniquement si le chemin effectif vers main le vérifie. Un registre déclaratif contournable, un compte partagé ou --actor ne prouvent pas une identité distincte. Vérifier les protections GitHub accessibles ; ne pas promettre zéro collision ou zéro blocage.

Livrer, intégrer puis publier



Une demande de file contient un identifiant idempotent, la base, le SHA de livraison, les fichiers et empreintes, le token courant, les catégories/covers, les mutations partagées souhaitées et les réserves. L’intégrateur relit base/livraison/main, reconstruit sur une tête fraîche et remet un reçu du commit résultant.

Si main avance, le push normal doit échouer : reprendre le candidat sur la nouvelle tête, refaire les contrôles affectés et ne jamais forcer main. En cas de conflit, suspendre seulement la demande concernée, conserver branche et preuves, reprendre un petit diff ; aucune résolution aveugle ours/theirs ni fusion globale d’un ancien arbre.

Les preuves de publication restent distinctes

Contrôler les gardes adaptées, liens, glossaire, fenêtres, quatre onglets, figures et navigation ; exécuter les tests et builds pertinents sur la version finale. Vérifier publication.json, audit/sources.json, le SHA construit, les routes publiques et les statuts provisoires. Un build réussi ne vaut pas audit médical ou disponibilité publique.

Veto et historique

Codex et Claude disposent du même veto motivé. Le journal de gouvernance reste append-only ; une IA ne lève pas le veto de l’autre sans instruction humaine applicable et tracée. La levée se fait dans un commit distinct. Préserver tous les anciens plans, sceaux, rapports, sources et décisions ; ne pas relancer les veilles ou ordonnanceurs historiques.

Le pilote et la décision de lancement

Cours pilote — intitulé	IA
G00 — Méningite bactérienne, non classée ailleurs	Codex
E03 — Autres hypothyroïdies	Claude
N00 — Syndrome néphritique aigu	Codex
C91 — Leucémie lymphoïde	Claude

Le pilote comporte quatre cours, deux par IA et un par système. Il vérifie les gardes adaptées, la complétude des preuves, la clarté du français, la charge réelle et l’absence de collision. Les quatre cours ne constituent pas un audit déjà effectué et ne lancent pas les autres lots.

Avant d’ouvrir les missions

Versionner le périmètre et l’attribution ; vérifier la tête de main et toutes les branches/PR paginées, livraisons, préparations et covers ; confirmer qu’aucun ancien cycle ou ordonnanceur n’écrit les mêmes chemins. Conserver les anciens plans comme sources documentaires, sans les réactiver.

Pour chaque mission : ouvrir missions/[assignment_id].json, confirmer IA/conversation, rôle, base SHA40, génération, branche/worktree, chemins propres et preuves. Ces manifestes ne sont pas des réservations actives. Lire le contrat compact par empreinte, puis les seules sections du socle nécessaires. Aucune copie globale d’un ancien arbre.

État : PREPARE_NON_LANCE. Aucun message à Claude, agent médical, rédaction, correction canonique, publication ou relance automatique n’est déclenché par ces PDF. Un lancement explicite et les adaptations vérifiées précèdent l’exécution.

Références : plan.json ; inventaire et CSV voisins ; prompt-verite-compact.yaml ; Prompt de vérité Betta (matrice exacte), PROMPT_MEDINA.md, PROMPT_TRANSITION.md, STYLE_REDACTION.md et instruction clarté/bases/calculs. La consigne actuelle s’applique aux quatre systèmes seulement ; les autres restent intacts.